

 ÉTUDE DE CAS · WEBESTHETIQUE.FR

Anatomie d'un site qui *gagne*.



Audit intégral du concurrent le plus avancé du marché, de son site de démonstration, et le blueprint du template lisadoc. Ce qu'il faut copier, ce qu'il faut battre, et comment le construire.

PRÉPARÉ POUR

Mouncef
lisadoc

MÉTHODE

Crawl intégral
127 pages mesurées

DATE DU RELEVÉ

5 septembre 2026

STATUT

Audit clos
Blueprint à valider

Ce qui a été mesuré, *et comment.*

Aucune affirmation de ce document ne repose sur une impression. Les deux sites ont été aspirés page par page, le 5 septembre 2026, et les chiffres proviennent des pages elles-mêmes.

Le protocole

- 01 **Inventaire.** Lecture du fichier robots et du plan de site. 99 adresses côté agence, 28 côté site de démonstration.
- 02 **Aspiration.** Les 127 pages téléchargées et conservées. Titres, descriptions, hiérarchie des titres, nombre de mots, données structurées, liens internes, images.
- 03 **Mesure technique.** Chargement réel en navigateur, poids transféré, nombre de requêtes, cookies déposés, domaines tiers appelés.
- 04 **Lecture.** Les pages commerciales, le programme de certification et une page d'acte lues intégralement, à la main.
- 05 **Rendu.** Captures desktop et mobile de trois pages clés.

Un relevé est daté. Un concurrent qui publie deux articles par semaine aura bougé dans trois mois. Les mécanismes, eux, ne bougeront pas.

Les deux objets

webesthetique.fr est le site de l'agence. Il vend aux praticiens. C'est le modèle de ce que sera *lisadoc.fr*.

demo.webesthetique.fr est leur site de démonstration, celui d'une chirurgienne fictive à Bordeaux. C'est le modèle du **template client**. C'est la pièce la plus utile des deux, et de loin.

Qui est ce concurrent

Une agence web française, spécialisée sur une seule famille de praticiens, les chirurgiens plasticiens et médecins esthétiques. Un homme seul, nommé et visible. Le discours est à la première personne du singulier.

Fourchette de prix affichée dans son balisage, sur les 98 pages du site : 5 000 à 12 000 euros. Un projet, pas un abonnement. Le prix varie selon le nombre d'interventions à décrire.

Positionnement en une phrase, la sienne. *Vous gérez votre cabinet. Je gère votre site. Toujours conforme. Toujours à jour.*

C'est le concurrent le plus proche de *lisadoc* qui existe aujourd'hui. Même client, même angle déontologique, même pari sur les IA. Une seule spécialité contre onze.

Ce que cet audit ne dit pas

Cinq limites, énoncées pour qu'aucune décision ne s'appuie sur une donnée que nous n'avons pas.

- **Aucun chiffre d'audience.** Nous ne savons pas combien de visiteurs ils reçoivent, ni sur quelles requêtes ils se classent réellement.
- **Aucun chiffre d'affaires.** Le nombre de clients, le taux de transformation et la rentabilité nous sont inconnus.
- **Aucune donnée de conversion.** Nous décrivons un parcours conçu, pas un parcours mesuré.
- **Aucune ancienneté.** Nous ignorons depuis combien de temps le site existe, donc à quelle vitesse ces 206 000 mots ont été produits.
- **Un instantané.** Relevé du 5 septembre 2026. Un site qui publie deux articles par semaine aura changé dans trois mois.

Pourquoi cela ne gêne pas

Aucune de ces inconnues ne change ce que nous cherchons ici : la structure, les mécanismes et les gabarits. Une architecture se lit dans les pages, pas dans les statistiques de son propriétaire.

Ce qui suit décrit donc **comment ce site est construit pour gagner**, et non de combien il gagne.

Sept mécanismes. *Un seul système.*

Ce site ne gagne pas parce qu'il est joli. Il gagne parce que sept mécanismes se renforcent l'un l'autre, et qu'aucun n'est copiable isolément.

206 298

 MOTS PUBLIÉS CÔTÉ
AGENCE

88 / 99

 PAGES PORTANT UN
BALISAGE DE QUESTIONS

155 Ko

 UNE PAGE D'ACTE, 8
REQUÊTES

0

 COOKIE, 0 DOMAINE
TIERS

- 01 **La conformité déontologique est transformée en produit.** Test gratuit en cinq minutes, audit, certification, badge affiché chez le praticien, registre public. Un référentiel privé, inventé de toutes pièces, dont ils sont l'autorité.
- 02 **Une équation qui tient en une phrase.** Le code de déontologie impose un contenu factuel, sans promesse ni superlatif. Les IA génératives citent exactement ce type de contenu. La contrainte et l'avantage sont la même chose. C'est l'idée la plus forte du site, et elle est déjà publique.
- 03 **Une autorité topique écrasante.** 79 articles, 177 867 mots, médiane de 1 843 mots. Chaque question que se pose un chirurgien esthétique sur son site a sa page. Il est impossible d'arriver sur ce marché par le contenu sans croiser leur nom.
- 04 **Le site patient est siloté par zone du corps, pas par nomenclature médicale.** Visage, seins, corps, médecine esthétique. Quatre pôles, dix-huit actes. Le patient pense en parties de son corps, pas en spécialités.
- 05 **Chaque page d'acte suit le même squelette de neuf sections,** sans exception sur les dix-huit pages. Environ 1 200 mots chacune. C'est industrialisable, vérifiable, et cela transforme la rédaction en remplissage de gabarit.
- 06 **Le balisage est complet et systématique.** Chaque page d'acte se déclare comme un acte médical et comme une page de questions. C'est ce qui la rend extractible par une machine.
- 07 **La sobriété technique est totale.** Site statique, huit requêtes, aucun cookie, aucun tiers. Donc rapide, donc conforme au RGPD sans effort, donc aucun bandeau de consentement à afficher.

La conclusion en une ligne

Leur appareil est excellent. *Leur preuve est vide.* Un seul site figure à leur registre de certification, et c'est leur propre démonstration.

La conformité déontologique, *transformée en produit.*

C'est le mouvement le plus intelligent du site, et le plus difficile à rattraper. Ils n'ont pas fait de la conformité un argument. Ils en ont fait une chaîne de quatre objets qui se vendent l'un l'autre.

01 · L'appât

Le test

Testez la conformité de votre site. Gratuit, cinq minutes, résultat immédiat. Placé en premier bouton de la page d'accueil, avant même le contact.

02 · La preuve

L'audit

Une page entière décrit ce que l'audit analyse. Le message est constant. Chaque site audité présentait au moins une violation.

03 · L'abonnement

La certification

Cinq niveaux de vérification, contrôlés chaque mois. Déontologie, RGPD, contenu à jour, jalons réglementaires. Une veille, donc une récurrence.

04 · Le verrou

Le badge

Un badge affiché dans le pied de page du praticien, plus un registre public des sites certifiés.

Le verrou, dans leurs mots

Si la veille cesse d'être assurée, fin d'abonnement ou départ vers un autre prestataire, le badge disparaît automatiquement du site du praticien et son entrée est retirée de ce registre.

WEBESTHETIQUE.FR · PAGE SITES CERTIFIÉS

Il faut mesurer ce que cette phrase fait. Le badge est servi en temps réel depuis leur serveur. Partir, ce n'est pas seulement changer de prestataire, c'est **faire disparaître de son propre site une marque de confiance que les patients ont vue**. C'est le mécanisme de rétention le plus fort que j'aie vu sur ce marché, et il ne coûte presque rien à opérer.

La rétention de lisadoc repose aujourd'hui sur la page vivante de questions et réponses. C'est plus noble, plus lent, et moins mécanique. Les deux ne s'excluent pas.

La faille de ce dispositif

Cette certification n'est adossée à aucune autorité. Elle est auto-décernée, auto-contrôlée, et porte le nom de l'agence. Le registre public compte **un seul site actif, qui est leur propre démonstration**.

Un praticien attentif verra qu'il devient le certifié numéro deux d'un référentiel inventé par son prestataire. Un confrère malveillant le verra aussi.

Ce qu'on en retient

Le diagnostic gratuit et instantané est à copier sans hésiter. Le badge de certification, non. lisadoc a mieux à jouer : **la date de vérification affichée sur chaque page**, sans badge, sans registre, sans prétention à certifier. La preuve sans la posture d'autorité.

L'équation. *La contrainte est l'avantage.*

Leur formulation, en page d'accueil

Le code de déontologie impose un contenu factuel, sans promesses ni superlatifs. Les IA génératives privilégient exactement ce type de contenu : précis, vérifiable, sans affirmations invérifiables. *La conformité déontologique et l'optimisation pour les moteurs IA produisent le même résultat.*

Pourquoi c'est juste

Un modèle de langage cite ce qu'il peut vérifier et attribuer. Il évite ce qui ressemble à une réclame. Or le code de déontologie interdit précisément la réclame : pas de promesse de résultat, pas de superlatif, pas de témoignage, pas de comparaison. Ce qui reste, une fois ces interdictions appliqués, est un texte factuel, daté, structuré, attribué à un praticien identifié et titré.

Autrement dit, **le praticien français est contraint par la loi d'écrire exactement le type de contenu que les machines préfèrent citer**. Ses concurrents internationaux, libres de faire de la publicité, écrivent des textes que les machines écartent.

C'est un renversement complet du discours habituel. La déontologie cesse d'être le frein qu'il faut contourner et devient l'actif qu'on exploite.

Ce que cela change pour lisadoc

Cette idée est le cœur intellectuel de la vente, et **elle est déjà publiée par un concurrent**. Elle ne peut donc plus servir de révélation, seulement de terrain commun. lisadoc doit la dépasser d'un cran.

Le cran suivant existe et personne ne l'occupe. Eux disent : le contenu conforme est citable. Le cran d'après : **le contenu conforme est citable, mais seule une réponse signée par un médecin identifiable est attribuable**. La signature n'est pas une formalité déontologique, c'est le signal d'attribution. C'est exactement la boucle de signature de la plateforme de marque, et c'est une longueur d'avance argumentaire.

La chaîne, en cinq maillons

- 01 La loi interdit au médecin d'acheter sa visibilité.
- 02 Son seul levier autorisé est ce qu'il publie.
- 03 Ce qu'il publie doit être factuel, sourcé, sans promesse.
- 04 C'est précisément ce qu'une IA accepte de citer.
- 05 Donc la contrainte qui l'enferme est aussi la seule porte ouverte.

La précaution qu'ils ne prennent pas

Ils affirment que 88 pour cent des patients recherchent leur praticien en ligne avant le rendez-vous, sans citer de source sur la page.

Le cadrage de lisadoc pose la règle inverse : aucun chiffre sans source et sans date. Tenir cette règle face à un concurrent qui ne la tient pas est un désavantage apparent et un avantage réel, à condition de le dire : *je ne vous donnerai que des chiffres que je peux sourcer.*

L'autorité topique. 79 articles, 177 867 mots.

Le blog n'est pas un blog. C'est un maillage de couverture : chaque question qu'un chirurgien esthétique peut taper au sujet de son site a sa page dédiée, optimisée, avec son balisage de questions.

79

ARTICLES PUBLIÉS

1 843

MOTS, MÉDIANE PAR ARTICLE

23

ARTICLES SUR LE SEO TECHNIQUE

17

ARTICLES SUR LES IA ET LE GEO

Les quatre familles de sujets

FAMILLE	VOL.	EXEMPLES DE TITRES, TELS QU'ILS SONT PUBLIÉS
SEO technique	23	maillage interne site chirurgien · balises title meta description médecin · schema org site médecin · vitesse chargement site médical · nombre pages intervention seo
Déontologie et droit	18	charte cnom site web médecin · mots interdits site chirurgien esthétique · photos avant après cadre légal · sanctions site médecin non conforme · rgpd site médecin obligations
IA et citation	17	chatgpt cite chirurgiens esthétiques · google ai overview chirurgie esthétique · perplexity gemini recherche médicale · geo vs seo chirurgien esthétique · voice search chirurgie esthétique
Décision et conversion	21	coût site internet chirurgien esthétique · doctolib site internet chirurgien · pourquoi site ne génère pas rdv · agence web généraliste vs spécialiste · roi site médecin rentabilisation

La quatrième famille est la plus commerciale et la plus redoutable. Elle occupe les requêtes de comparaison : *Doctolib suffit-il, agence généraliste ou spécialiste, combien coûte un site*. Un praticien qui commence à se renseigner tombe sur leur réponse à ces questions, écrite par eux, avant de parler à qui que ce soit.

Le calcul, sans détour

177 867 mots. À 1 200 mots par heure de rédaction soignée, avec relecture, cela représente de l'ordre de **150 heures de production**, sans compter la recherche de sujets.

C'est un investissement, pas un miracle. Et c'est reproductible. Mais c'est du temps qui ne sera pas passé à livrer des sites clients. Le cadrage de lisadoc le note déjà pour la publication : *c'est un second métier, en concurrence avec la livraison pour le temps*.

La stratégie qui bat celle-ci

Ne pas les affronter sur leur terrain. Ils couvrent **les questions que se pose le chirurgien esthétique sur son site web**. C'est une seule spécialité, et c'est un sujet de prestataire.

lisadoc travaille onze spécialités. Sa couverture naturelle est **les questions que se posent les patients de chaque spécialité**, publiées sur les sites des praticiens, pas sur le sien. Le volume total est bien supérieur, il est distribué chez les clients, et il fait leur référencement pendant qu'il fait le nôtre.

Le silo par *zone du corps*, pas par nomenclature.

C'est la décision d'architecture la plus importante du site de démonstration, et elle tient en une phrase. Un patient ne cherche pas une spécialité, il cherche la partie de lui qui le gêne.

L'arborescence complète, 28 pages

/	accueil
/le-docteur/	le praticien
/premiere-consultation/	le parcours de soin
/contact/	
/visage/	pôle
rhinoplastie	
rhinoplastie-ultrasonique	
lifting-cervico-facial	
blepharoplastie	
otoplastie	
genioplastie	
/seins/	pôle
augmentation-mammaire	
lipofilling-mammaire	
reduction-mammaire	
mastopexie	
/corps/	pôle
liposuccion	
abdominoplastie	
lifting-des-bras	
lifting-des-cuisses	
/medecine-esthetique/	pôle
injection-acide-hyaluronique	
injection-toxine-botulique	
peelings	
skinbooster	
/mentions-legales/	
/politique-de-confidentialite/	

Ce que fait cette structure

Quatre pôles, dix-huit actes, quatre pages de service. Trois pôles sont des zones du corps. Le quatrième est une famille de gestes non chirurgicaux. Aucun pôle ne porte un nom de discipline médicale.

Chaque acte est à deux clics de l'accueil et à un clic depuis n'importe quelle page, par le menu déroulant et par le pied de page qui répètent la liste complète. Nous avons compté entre 117 et 140 liens internes par page.

Chaque page d'acte est une page locale. Le titre affiché porte l'acte et la ville. Dix-huit actes, c'est dix-huit portes d'entrée locales, pas une.

Le pôle capte la requête large, l'acte capte la requête précise. Le patient qui cherche une chirurgie du nez et celui qui cherche une rhinoplastie ultrasonique atterrissent tous les deux au bon endroit.

La transposition pour lisadoc

Le pôle change de nature selon la spécialité, mais la règle ne change pas : **le premier niveau porte le mot du patient, jamais celui du médecin.**

OPHTALMOLOGIE	Vision de loin · Cataracte · Paupières · Rétine
GYNÉCOLOGIE	Suivi et grossesse · Difficultés à concevoir · Ménopause · Chirurgie
ORTHOPÉDIE	Genou · Hanche · Épaule · Main et poignet · Pied
ORL	Nez et sinus · Oreille et audition · Gorge et voix · Sommeil

Le découpage se valide avec le praticien pendant l'entretien. C'est la première question de la grille d'actes.

Le squelette d'acte. *Neuf sections, dix-huit fois.*

Les dix-huit pages d'acte portent exactement les mêmes neuf titres de section, dans le même ordre, pour une moyenne de 1 223 mots. Aucune exception. C'est ce qui rend la production industrialisable et le résultat vérifiable.

SECTION	CE QU'ELLE FAIT VRAIMENT
01 Qu'est-ce que [l'acte] ?	Définition en deux paragraphes. C'est le bloc que les IA extraient en premier. Il contient les synonymes que le patient emploie.
02 Indications	Liste à puces des situations concernées. Le patient s'y reconnaît, ou pas. C'est le tri par auto-diagnostic, sans jamais diagnostiquer.
03 Déroulement	Sous-titré en avant, le jour, après. Chiffré partout : durée, type d'anesthésie, délais d'arrêt des traitements.
04 Suites opératoires	Œdème, arrêt de travail, reprise du sport, délai de résultat. Ce sont les questions qui font appeler le secrétariat.
05 Résultats	Factuel, sans image, sans promesse. La section la plus contrainte, et ils la tiennent.
06 Risques et complications	Liste franche. Obligation d'information loyale, et paradoxalement le bloc qui inspire le plus confiance.
07 Tarifs et prise en charge	Ce qui est remboursé, ce qui ne l'est pas, le devis. Première cause d'avis négatif quand elle manque.
08 Questions fréquentes	Quatre questions, balisées. C'est la surface de citation par les IA et les extraits enrichis.
09 Prendre rendez-vous	Conversion en bas de page, après l'information, jamais avant.

Les trois blocs périphériques

Le panneau latéral collant. Bouton de rendez-vous, téléphone, puis un encart informations clés : anesthésie, durée, hospitalisation, délai légal. Quatre faits scannables en trois secondes.

L'encart réglementaire, en pied de page d'acte. Rappel que tout acte comporte des risques, mention du délai de réflexion de quinze jours au titre de l'article L.6322-2, et du devis détaillé. Composant unique, réutilisé partout.

Interventions associées. Trois liens vers des actes voisins, plus un lien vers la page parcours de soin. Le maillage se fait par le contenu, pas seulement par le menu.

Et la ligne qui compte : *Contenu vérifié : Mars 2026.* Une date de vérification affichée sur chaque page.

Pourquoi ce squelette gagne

Il suit l'ordre exact des questions d'un patient inquiet : c'est quoi, est-ce pour moi, comment ça se passe, combien de temps je serai arrêté, à quoi je peux m'attendre, qu'est-ce qui peut mal tourner, combien ça coûte, et enfin comment je vous vois.

La conversion arrive en neuvième position, et c'est pour cela qu'elle fonctionne.

Le balisage. *Écrit pour être extrait.*

Une page bien écrite ne suffit pas. Elle doit se déclarer. Sur les deux sites, le balisage est systématique, jamais décoratif, et c'est ce qui autorise une machine à reprendre le contenu en citant la source.

Ce qui est déclaré, où

TYPE DÉCLARÉ	PAGES	RÔLE
Physician	28 / 28	Le praticien, sur tout le site patient.
MedicalBusiness	28 / 28	Le cabinet, l'adresse, les horaires.
MedicalProcedure	18 / 18	Sur chaque page d'acte. C'est la déclaration qui compte.
FAQPage	18 / 18	Les questions fréquentes, structurées.
BreadcrumbList	27 / 28	Le chemin, donc la hiérarchie.
ProfessionalService	98 / 99	Côté agence, avec la fourchette de prix.
FAQPage (agence)	88 / 99	Presque chaque page de l'agence porte des questions balisées.
BlogPosting	79 / 79	Chaque article, daté et attribué.

Le fait marquant n'est pas la liste, c'est la **couverture**. 88 pages sur 99 côté agence, 18 sur 18 côté patient. Il n'y a pas de page oubliée. C'est le signe d'un gabarit, pas d'un travail à la main.

Le squelette à reproduire, par page d'acte

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "MedicalProcedure",
      "name": "Rhinoplastie",
      "procedureType":
        "https://schema.org/SurgicalProcedure",
      "bodyLocation": "Nez",
      "howPerformed": "...",
      "preparation": "...",
      "followup": "...",
      "performer": { "@id": "#physician" } },
    {
      "@type": "FAQPage",
      "mainEntity": [ { "@type": "Question",
        "name": "...",
        "acceptedAnswer": { "@type": "Answer",
          "text": "..." } } ],
      { "@type": "Physician", "@id":
        "#physician",
        "name": "Dr ...", "medicalSpecialty": "...",
        "address": {...}, "telephone": "..." },
      { "@type": "BreadcrumbList",
        "itemListElement": [...] }
    ]
  ]
}
```

Ce que lisadoc ajoute

Deux propriétés qu'ils n'exploitent pas et qui portent la signature : `author` et `dateModified` pointant sur le praticien identifié, avec son numéro RPPS le cas échéant, et `reviewedBy` renvoyant à la même personne.

Une réponse attribuée à un médecin identifiable et vérifiable n'est pas de même nature qu'un texte anonyme. **C'est le seul terrain où un site de praticien bat structurellement un site d'agence ou un forum.**

La sobriété technique. *Zéro cookie, huit requêtes.*

Mesures prises en navigateur réel, le 5 septembre 2026, connexion de bureau.

MESURE	PAGE D'ACTE	ACCUEIL PATIENT	ACCUEIL AGENCE	LECTURE
Poids transféré	155 Ko	309 Ko	197 Ko	Un site de cabinet médical courant se situe entre 2 et 5 Mo.
Requêtes réseau	8	14	9	Un site sous gestionnaire de contenu avec extensions en fait couramment 60 à 120.
Cookies déposés	0	0	0	Donc aucun bandeau de consentement, donc aucune friction à l'arrivée.
Domaines tiers	0	0	1	Côté patient, rien ne sort du domaine. Côté agence, une mesure d'audience sans cookie.
Contenu interactif prêt	1 141 ms	1 116 ms	1 057 ms	Sur mobile en 4G, l'écart avec un site lourd se compte en secondes.
Images	5	11	3	Format moderne, chargement différé au-delà du premier écran.

Comment ils y arrivent

Un générateur de site statique. Aucune base de données à l'exécution, aucune extension, aucune bibliothèque d'animation. Les polices sont hébergées sur le domaine, en un seul format moderne, trois fichiers. La feuille de style critique est intégrée dans la page. Les images sont converties et dimensionnées à la construction.

Le cadrage de lisadoc contient déjà cette ligne : *un beau site est un site qu'on trouve facilement et qui se charge rapidement*. C'est la même école. L'audit confirme simplement que le concurrent l'applique déjà, et qu'il faut donc faire aussi bien, pas mieux : à ce niveau, il n'y a plus de gain perceptible à gagner.

Le bénéfice caché de zéro cookie

Sans cookie de traçage, il n'y a pas de bandeau de consentement. Sans bandeau, il n'y a pas de refus. Sans refus, **la mesure d'audience porte sur cent pour cent des visiteurs**, et non sur la moitié consentante.

Conséquence directe pour lisadoc : le compteur de demandes de rendez-vous promis au praticien devient exact plutôt qu'approximatif. La promesse vérifiable à douze mois repose sur ce détail technique.

De la peur du patient *au virement du praticien.*

Les deux sites forment une seule machine à deux étages. En bas, le patient trouve son praticien. En haut, le praticien trouve l'agence. Les deux parcours utilisent le même ressort : informer d'abord, demander ensuite.

Étage 1 • le patient, sur le site du praticien

- 01 Il tape un problème ou un acte, souvent avec une ville. Il atterrit sur la page d'acte, pas sur l'accueil.
- 02 Il lit la définition, se reconnaît dans les indications.
- 03 Il cherche ce qui l'inquiète vraiment : la douleur, l'arrêt de travail, le prix. Les sections 4 et 7 y répondent sans détour.
- 04 Il regarde qui parle. Un clic vers la page du praticien, titres et parcours.
- 05 Il vérifie le déroulé administratif sur la page première consultation, y compris le délai légal.
- 06 Il prend rendez-vous, ou il appelle. Le numéro est visible sur chaque écran.

Le point remarquable. Aucune sollicitation avant la sixième étape. Pas de fenêtre surgissante, pas de discussion automatique, pas de formulaire barrant la lecture.

Étage 2 • le praticien, sur le site de l'agence

- 01 Il cherche une question de prestataire : combien coûte un site, Doctolib suffit-il, ai-je le droit de publier telle photo. Un des 79 articles répond.
- 02 L'article le renvoie vers le test de conformité gratuit. Cinq minutes, résultat immédiat.
- 03 Le test lui apprend qu'il est en infraction, sans le culpabiliser : personne ne lui a jamais expliqué les règles.
- 04 Il regarde le site de démonstration et voit exactement ce qu'il achèterait.
- 05 Il demande un échange de trente minutes. L'engagement en temps est annoncé partout : une visio et quelques validations.

Le point remarquable. Le premier appel à l'action de la page d'accueil n'est pas *contactez-nous*, c'est *testez votre conformité*. On donne un diagnostic avant de demander un rendez-vous. C'est exactement la logique du document d'étude par spécialité, en version automatique et instantanée.

Ce qu'ils promettent en temps

Une visio de trente minutes et quelques validations. lisadoc annonce quarante-cinq minutes d'entretien. **Nous sommes plus chers en temps et nous devons l'assumer** : quarante-cinq minutes parce que le contenu vient de sa voix, pas d'un formulaire.

Ce qu'ils ne montrent pas

Aucun prix sur le site, sauf dans le balisage technique. Le praticien doit appeler pour savoir. lisadoc affiche ses prix, totaux compris. **C'est un avantage de confiance immédiat**, et il se dit à voix haute.

Ce qu'ils font mieux

L'entrée par un outil plutôt que par une conversation. Un praticien peut se diagnostiquer seul, à minuit, sans parler à personne. **C'est le seul élément du dispositif qu'il faut copier tel quel.**

Six points où *ils sont attaquables*.

Un audit qui ne trouve que des qualités n'est pas un audit. Voici ce qui est réellement exploitable, par ordre d'importance.

LA FAILLE	LE CONSTAT, VÉRIFIABLE	CE QUE LISADOC EN FAIT
01 La preuve est vide CRITIQUE	Le registre public des sites certifiés compte un seul site actif , et c'est leur propre démonstration, signée par une praticienne fictive. La page réalisations montre le même site unique.	Le premier site de lisadoc sera celui d'une praticienne réelle, exerçante, nommée. Un site réel bat une démonstration , même moins belle. Ne jamais attaquer là-dessus en public : le montrer suffit.
02 La certification est auto-décernée STRUCTUREL	Un badge de conformité déontologique délivré par le prestataire lui-même, sans autorité tierce, apposé sur le site d'un médecin soumis à un ordre professionnel.	Ne pas imiter. Afficher la date de vérification, citer les textes, et laisser l'Ordre être la seule autorité. Notre preuve est la traçabilité, pas le label.
03 Une seule spécialité STRATÉGIQUE	Tout le dispositif est calibré pour la chirurgie et la médecine esthétique. C'est leur force de frappe et leur plafond.	Onze spécialités visées, dont plusieurs sans aucun acteur spécialisé. La chirurgie esthétique est le seul terrain à éviter au lancement : il est tenu.
04 Des chiffres sans source EXPLOITABLE	Le chiffre de 88 pour cent de patients qui recherchent en ligne est affiché en page d'accueil sans référence.	Tenir la règle du cadrage, aucun chiffre sans source, et le dire . C'est une différence de tenue qu'un médecin repère immédiatement.
05 Le registre de la peur DE TON	Le message dominant est l'exposition : chaque site audité est en infraction, vous vous exposez sans le savoir. C'est efficace, et c'est un levier anxiogène.	Le cadrage de lisadoc interdit le vocabulaire de peur. Tenir cette ligne coûtera des conversions à court terme et fabriquera une réputation à long terme. C'est un arbitrage à assumer, pas à contourner.
06 Des défauts d'exécution MINEUR	La page à propos est vide , huit mots, alors qu'elle figure au menu et au plan de site. La page réalisations tient en 289 mots.	Rappel utile : un dispositif impressionnant peut cacher des trous béants. Vérifier chaque page de notre propre site avant mise en ligne, y compris les pages secondaires.

Une remarque de méthode

Aucune de ces six failles ne doit devenir un argument de vente nommant le concurrent. Le cadrage l'interdit et le bon sens aussi : attaquer un confrère du métier devant un médecin qui a l'interdiction d'attaquer les siens produit exactement le mauvais effet. **Ces failles servent à choisir notre terrain, pas à ouvrir un procès.**

Où lisadoc gagne, où lisadoc perd.

Comparaison honnête, en l'état des deux offres au 5 septembre 2026. Le cadrage de lisadoc est une intention, leur site est une réalité en ligne. C'est le principal écart.

TERRAIN	WEBESTHÉTIQUE, CONSTATÉ	LISADOC, TEL QUE CADRÉ	VERDICT
Existence en ligne	99 pages, 206 298 mots, en ligne et indexées.	Rien de publié à ce jour.	RETARD
Preuve client	Une démonstration fictive. Zéro client public.	Un premier site réel prévu, praticienne exerçante.	AVANTAGE
Périmètre	Une famille de spécialités, saturée en communication.	Onze spécialités, dont plusieurs vierges.	AVANTAGE
Modèle économique	Projet de 5 000 à 12 000 euros. Revenu non récurrent.	Mise en place plus abonnement. Revenu récurrent, promesse du dernier site.	AVANTAGE
Transparence des prix	Aucun prix public, sauf dans le balisage.	Prix affichés, totaux compris.	AVANTAGE
Angle déontologique	Occupé, outillé, productisé, publié.	Revendiqué, non encore outillé.	RETARD
Diagnostic d'entrée	Automatique, gratuit, instantané.	Manuel, par étude de spécialité, plus riche mais plus lent.	À COMBINER
Voix du praticien	Contenu rédigé par l'agence à partir de sources documentaires. Aucun entretien mentionné.	Entretien enregistré de 45 minutes, contenu issu de ses mots, signature du praticien.	AVANTAGE DÉCISIF
Contenu vivant	Contenu figé, revérifié mensuellement.	Brique de questions et réponses alimentée par les patients.	AVANTAGE
Rétention	Le badge disparaît si l'abonnement s'arrête. Mécanique et immédiate.	Page vivante et site qui ne vieillit pas. Douce et lente.	PLUS FAIBLE
Technique	Statique, 155 Ko, zéro cookie.	Même exigence inscrite au cadrage.	ÉGALITÉ

La lecture stratégique

Sur onze terrains, lisadoc gagne six fois, perd trois fois, et égalise deux fois. Les trois retards sont tous des retards d'exécution, pas de conception : publier, outiller le diagnostic, durcir la rétention. Aucun ne demande de changer la stratégie.

L'avantage décisif tient en un mot : *l'entretien*. Ils écrivent sur le praticien. Nous écrivons à partir du praticien.

Le principe directeur, *puis l'arborescence.*

La règle qui commande toutes les autres

Une page par question que se pose un patient. *Jamais une page par service que vend le cabinet.*

Toute l'architecture qui suit découle de cette phrase. Elle décide du découpage, des adresses, des titres, du maillage et du contenu. Quand un arbitrage se présente, c'est elle qui tranche.

Arborescence de référence, palier Visibilité, 34 pages

/	accueil
/le-docteur/	le praticien
/le-cabinet/	lieu, accès, équipe
/premiere-consultation/	parcours et délais
/honoraires/	tarifs, conventionnement
/contact/	rdv, plan, horaires
/[pôle-patient-1]/	hub
/[pôle-1]/[acte-a]/	
/[pôle-1]/[acte-b]/	
/[pôle-1]/[acte-c]/	
/[pôle-patient-2]/	hub
/[pôle-2]/[acte-d]/	
...	
/[pôle-patient-3]/	hub
/[pôle-patient-4]/	hub
/questions/	index Q/R, brique
/questions/[question]/	
/mentions-legales/	
/politique-de-confidentialite/	
/accessibilite/	déclaration

Six pages de socle, quatre pôles, vingt-quatre pages d'acte, l'index de questions, trois pages légales. Le palier Identité retire les pôles et garde dix pages. Le palier Autorité double le nombre d'actes et ouvre les pages de pathologie.

Les quatre écarts assumés

Une page honoraires autonome. Chez eux, les tarifs sont une section dans chaque acte. Nous gardons cette section *et* nous ajoutons une page dédiée. Le cadrage identifie les dépassements comme première cause d'avis négatif : cela mérite une page qu'on peut envoyer avant la consultation.

Une page cabinet. Accès, parking, transports, étage, ascenseur, accessibilité. Ce sont des questions réellement posées au secrétariat, et personne n'y répond en ligne.

Un index de questions. La brique Q/R a besoin d'une adresse à elle. Chaque question validée devient une page ou une ancre, donc une porte d'entrée supplémentaire, dans les mots exacts des patients.

Une déclaration d'accessibilité. Peu de sites médicaux en ont. C'est cohérent avec l'accueil comme valeur, et cela se voit.

Ce qu'on ne met pas

Pas de blog sur le site du praticien. Un blog vieillit, culpabilise et finit abandonné. Les questions patients remplacent le blog, et elles, elles se remplissent toutes seules.

Douze types de page. *Pas un de plus.*

Un type de page est un gabarit : une structure, un budget de mots, un balisage, un objectif. Douze gabarits couvrent tous les sites, toutes spécialités confondues. C'est ce qui rend la production répétable et le prix tenable.

	TYPE	MOTS	OBJECTIF UNIQUE	BALISAGE
01	Accueil	700 à 900	Orienter en trois secondes vers le bon pôle. Rassurer sur l'identité.	Physician, MedicalBusiness, WebSite
02	Praticien	700 à 1 000	Établir la légitimité : titres, formations, parcours, orientations.	Physician, EducationalOccupationalCredential
03	Cabinet	400 à 600	Répondre aux questions pratiques d'accès et d'organisation.	MedicalBusiness, Place, OpeningHours
04	Pôle	500 à 700	Capter la requête large et distribuer vers les actes.	MedicalSpecialty, BreadcrumbList
05	Acte	1 100 à 1 400	Répondre entièrement à une intervention. Le cœur du dispositif.	MedicalProcedure, FAQPage
06	Pathologie	900 à 1 200	Répondre à la requête symptôme, en amont de l'acte. Palier Autorité.	MedicalCondition, FAQPage
07	Parcours	800 à 1 000	Dérouler consultation, délai légal, intervention, suivi.	HowTo, BreadcrumbList
08	Honoraires	500 à 700	Dire franchement conventionnement, dépassements, remboursement, devis.	MedicalBusiness, FAQPage
09	Question	200 à 400	Une question de patient, une réponse signée et datée. Brique Q/R.	QAPage, Person (author)
10	Index questions	300 à 500	Regrouper et hiérarchiser les questions par pôle.	CollectionPage, ItemList
11	Contact	300 à 500	Prendre rendez-vous, appeler, venir. Zéro friction.	ContactPage, MedicalBusiness
12	Légale	libre	Mentions, confidentialité, accessibilité. Obligations.	WebPage

Pourquoi douze

Chaque type supplémentaire ajoute un gabarit à concevoir, à tester, à maintenir et à expliquer. Douze couvre tout. Au-delà, on fabrique de la dette.

Le budget de mots

Il n'est pas décoratif. Sous 900 mots, une page d'acte ne répond pas. Au-delà de 1 500, elle n'est plus lue sur un téléphone. La fourchette est un cahier des charges de rédaction.

Le type 09, spécifique

C'est le seul type qui grandit tout seul après la livraison. Trois ans de questions signées produisent un actif qu'aucune agence ne peut recréer en repartant de zéro.

La page d'acte lisadoc. *Onze sections.*

Le squelette du concurrent en compte neuf. Nous en ajoutons deux, et nous n'en retirons aucune. Les deux ajouts sont précisément ce qu'ils ne peuvent pas produire.

SECTION	CE QU'ELLE CONTIENT, ET POURQUOI
00 En bref AJOUT	Cinq faits, en haut de page, avant tout le reste. Durée, anesthésie, hospitalisation, arrêt de travail, délai de résultat. C'est le bloc qu'une IA extrait et cite , et c'est ce qu'un patient pressé cherche d'abord.
01 Qu'est-ce que c'est	Définition en deux paragraphes, avec les synonymes du patient.
02 Est-ce pour vous	Les indications, écrites en situations vécues plutôt qu'en critères cliniques.
03 Le mot du Dr [X] AJOUT	Trois à cinq phrases tirées de l'entretien, dans ses mots, signées . Sa manière de poser l'indication, ce qu'il refuse d'opérer, ce qu'il dit toujours en consultation. Personne ne peut copier ce bloc.
04 Comment ça se passe	Avant, le jour, après. Chiffré partout.
05 Les suites	Douleur, arrêt de travail, sport, conduite, délais réels.
06 Les résultats	Factuel, sans image de résultat, sans promesse.
07 Risques et complications	Liste franche. Obligation d'information loyale, article R.4127-35.
08 Tarifs et prise en charge	Conventionnement, base de remboursement, dépassement, devis, délai légal si applicable.
09 Questions des patients	Quatre questions au lancement, puis la brique vivante. Chaque réponse datée et signée.
10 Prendre rendez-vous	En bas, après l'information. Jamais avant.

Les blocs périphériques

- **Panneau latéral collant** : rendez-vous, téléphone, puis les cinq faits de la section 00.
- **Encart réglementaire** : risques, devis, délai de réflexion. Composant unique.
- **Sources** : renvois aux sociétés savantes et aux autorités sanitaires. Ils n'en ont pas. **C'est un signal d'attribution majeur.**
- **Actes associés** : trois liens, plus le parcours de soin.
- **Vérifié le [date] par [Dr X]** : la ligne qui remplace leur badge.

Pourquoi la section 03 change tout

Deux pages d'acte écrites à partir des mêmes sources documentaires se ressemblent, quel que soit le rédacteur. C'est le plafond de toute agence qui écrit *sur* un praticien.

Une page qui contient trois phrases du praticien lui-même, sur sa manière de poser l'indication, devient unique, non copiable et attribuable. C'est la promesse de la plateforme de marque, rendue visible à l'endroit exact où le patient décide.

Une seule section, et le site cesse d'être *un site d'agence*.

Adresses, titres, *maillage*.

Le système d'adresses

```

/[pole]/          → hub
/[pole]/[acte]/   → acte
/pathologies/[pathologie]/ → pathologie
/questions/[question]/ → question patient
/le-docteur/ /le-cabinet/ /honoraires/
/premiere-consultation/ /contact/

```

- Tout en minuscules, sans accent, séparé par des traits d'union.
- Deux niveaux au maximum. Jamais de date, jamais d'identifiant.
- Le mot exact du patient, pas l'intitulé de la nomenclature.
- Barre oblique finale, cohérente sur tout le site.
- Le nom de domaine porte **Jamais** la charte ordinale
- L'identité du praticien. **un** l'exclut et cela
- **mot-clé** n'apporte rien au classement.

Les titres

BALISE [Acte] à [Ville] · Dr [Nom], [spécialité]
TITRE

TITRE H1 Surtitre [ACTE] À [VILLE], puis phrase de bénéfice en clair

DESCRIPTION Une phrase factuelle, la durée, l'anesthésie, et le cabinet. Aucune promesse.

Le surtitre porte la requête, le titre visible porte la langue humaine. Les deux dans le même bloc de titre. C'est leur trouvaille, elle est bonne, on la garde.

Le maillage, en cinq règles

- 01 Menu complet.** La liste de tous les actes est accessible depuis chaque page, par le menu et par le pied de page. Cent à cent quarante liens internes par page : c'est volontaire, pas accidentel.
- 02 Fil d'Ariane.** Accueil, pôle, acte. Balisé. Il donne la hiérarchie à la machine et le repère au patient.
- 03 Trois actes associés** en bas de chaque page d'acte, choisis par proximité de décision et non par ordre alphabétique.
- 04 Chaque acte renvoie au parcours de soin et aux honoraires.** Ce sont les deux pages qui lèvent les dernières objections.
- 05 Chaque question renvoie à son acte, et chaque acte à ses questions.** C'est ce qui fait vivre la brique Q/R et la rend utile au référencement.

La règle du deuxième clic

Depuis n'importe quelle page, un patient atteint n'importe quel acte en un clic, et le rendez-vous en un clic. **Si un contenu demande trois clics, il n'existe pas.** C'est le test à faire sur chaque maquette, avant de parler d'esthétique.

Les huit erreurs d'adresses les plus fréquentes

- **NON** Une date dans l'adresse. Le contenu vieillit à vue d'œil.
- **NON** Un mot-clé dans le nom de domaine. Exclu par la charte ordinale, sans effet sur le classement.
- **NON** /nos-services/ ou /nos-prestations/. Vocabulaire de prestataire.
- **NON** Un sous-domaine séparé pour le contenu. L'autorité se disperse.
- **NON** Un identifiant technique ou une extension de fichier.
- **NON** Un document PDF là où une page était nécessaire.
- **NON** Une page unique listant tous les actes, sans page par acte.
- **NON** Un changement d'adresse sans redirection. Tout le travail acquis disparaît.

La règle de la refonte

Quand nous reprenons un site existant, chaque ancienne adresse reçoit une redirection permanente vers sa correspondance nouvelle. Une seule, jamais en chaîne.

C'est la première cause d'effondrement après une refonte, et c'est aussi ce qui explique qu'un praticien puisse avoir payé trois sites et se retrouver moins visible qu'avant.

Le balisage, *type par type*.

Un seul bloc de données structurées par page, en graphe, avec des identifiants réutilisables. Le praticien et le cabinet sont déclarés une fois et référencés partout.

TYPE DE PAGE	CE QUI EST DÉCLARÉ
Toutes	WebSite · Physician (identifiant #doc) · MedicalBusiness (identifiant #cab) · BreadcrumbList
Praticien	Le nœud #doc enrichi : medicalSpecialty, alumniOf, hasCredential, memberOf, identifier pour le RPPS
Cabinet	#cab enrichi : address, geo, openingHoursSpecification, isAcceptingNewPatients, paymentAccepted
Pôle	CollectionPage + ItemList des actes du pôle, dans l'ordre d'affichage
Acte	MedicalProcedure avec bodyLocation, preparation, howPerformed, followup, performer → #doc · plus FAQPage
Pathologie	MedicalCondition avec signOrSymptom, possibleTreatment → l'acte correspondant
Parcours	HowTo, une étape par temps du parcours, avec les délais réels
Question	QAPage · author → #doc · dateModified · upvoteCount jamais

La règle de probité qui vaut pour tout le balisage : on ne déclare que ce qui est visible sur la page. Un balisage qui promet ce que le texte ne dit pas est une faute technique, et sur un site médical, une faute tout court.

Ce qu'on ne déclare jamais : AggregateRating, Review, Offer avec un prix d'acte. Les deux premiers sont des avis de patients, interdits. Le troisième transforme un acte de soin en produit.

Le nœud praticien, une fois pour tout le site

```
{ "@type": "Physician",
  "@id": "https://.../#doc",
  "name": "Dr ...",
  "honorificPrefix": "Dr",
  "medicalSpecialty": "...",
  "identifier": {
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "RPPS", "value": "..."
  },
  "alumniOf": "...",
  "hasCredential": [ ... ],
  "worksFor": { "@id": ".../#cab"
},
  "url": "https://.../le-docteur/"
}
```

Le numéro RPPS est public et vérifiable dans l'annuaire santé. Le déclarer relie le site à une identité contrôlée par l'État.

Aucune agence généraliste ne pense à le faire, et c'est le signal d'attribution le plus fort disponible.

La vérification, à chaque livraison

- Aucune erreur dans l'outil de test de Google.
- Un seul bloc de données par page.
- Chaque identifiant résolu, aucun nœud orphelin.
- Les dates de modification réelles, jamais automatiques.

Vingt composants. *Tout le système.*

Un site entier se construit avec vingt briques. Les dessiner une fois, bien, puis les réutiliser sur tous les clients : c'est ce qui rend la refonte gratuite tenable et le délai de livraison prévisible.

Structure

01 En-tête	Identité, menu, téléphone, rendez-vous. Collant sur mobile.
02 Menu des pôles	Déroulant, liste complète des actes, quatre colonnes.
03 Fil d'Ariane	Trois niveaux, balisé.
04 Pied de page	Liste complète, coordonnées, horaires, mentions, accessibilité.
05 Panneau latéral collant	Rendez-vous, téléphone, faits clés. Se replie en barre basse sur mobile.

Contenu

06 Bloc en bref	Cinq faits, en tête de page d'acte.
07 Section de texte	Titre, deux à quatre paragraphes, mesure de ligne contrainte.
08 Liste d'indications	Puces courtes, une situation par ligne.
09 Étapes	Avant, pendant, après. Numérotées, avec délais.
10 Citation du praticien	Verbatim signé, fond distinct, mention entretien du [date].
11 Tableau tarifs	Acte, base de remboursement, dépassement, devis.
12 Accordéon questions	Ouvert par défaut sur desktop, replié sur mobile. Balisé.

Confiance

13 Encart réglementaire	Risques, devis, délai de réflexion. Texte figé, réutilisé.
14 Bloc sources	Deux à quatre renvois aux autorités et sociétés savantes.
15 Ligne de vérification	Contenu vérifié le [date] par le [Dr X].
16 Carte praticien	Portrait, titres, RPPS, lien vers la page complète.

Action

17 Bloc rendez-vous	Bouton agenda, téléphone, horaires. Répété en fin de page.
18 Formulaire question	Brique Q/R. Avertissement urgence en tête, anonymisation annoncée.
19 Actes associés	Trois cartes, choisies par proximité de décision.
20 Carte et accès	Plan statique, sans traceur tiers, transports et stationnement.

Ce qui n'existe pas dans le système

Pas de carrousel. Pas de compteur animé. Pas de fenêtre surgissante. Pas de discussion automatique. Pas de galerie avant-après. Pas de bandeau de cookies, puisqu'il n'y a pas de cookie. Pas de note ni d'étoile.

Chaque absence est une décision, et chacune se justifie devant le praticien en une phrase. C'est le meilleur moment de la présentation.

Le comportement mobile est spécifié une fois, pas improvisé. Le panneau latéral collant devient une barre basse à deux actions, appeler et prendre rendez-vous. Le menu des pôles s'ouvre en pleine page. L'accordéon de questions se replie. Le tableau des tarifs passe en liste. Le reste ne change pas : les composants sont dessinés pour le téléphone d'abord, et élargis ensuite.

Le modèle de contenu. *Ce qu'on collecte, une fois.*

C'est le document le plus important de la production. Si ces champs sont remplis, le site s'écrit presque tout seul, par un humain comme par une machine. S'ils manquent, aucune quantité de talent ne rattrape.

Fiche praticien · collectée une fois

```
nom, titre, sexe, RPPS, spécialité
diplômes[] {intitulé, université, année}
formations[] {intitulé, organisme, année}
titres[] {hospitalier, universitaire}
sociétés_savantes[]
langues[]
secteur_conventionnement
moyens_de_paieement[]
lieux[] {nom, adresse, horaires, accès,
        parking, transports, ascenseur}
photo_portrait, photos_cabinet[]
trois_sentiments[] ← direction visuelle
pourquoi_cette_spécialité ← verbatim
ce_que_je_dis_toujours ← verbatim
```

Les trois derniers champs sortent de l'entretien et ne s'obtiennent pas autrement. **Ce sont eux qui font la différence entre un site de lisadoc et un site d'agence.**

Fiche acte · une par acte coché

```
nom_patient ← le mot du patient
nom_médical ← la nomenclature
pôle
synonymes[]
définition
indications[]
contre_indications[]
anesthésie, durée, hospitalisation
préparation[] ← avant
déroulé[] ← le jour
suites[] ← après
arrêt_travail, reprise_sport, conduite
délai_résultat
risques[]
prise_en_charge {conventionné, base_rembt,
                 dépassement, devis,
délai_légal}
questions[] {q, réponse, date, signé_par}
verbatim_praticien ← section 03
sources[]
actes_associés[]
vérifié_le
```

D'où vient chaque champ

Environ quatre-vingts pour cent sont pré-remplis par nous avant l'entretien : nomenclature, sources, structure. Le praticien corrige. Les champs verbatim, les délais réels de sa pratique et les contre-indications qu'il retient viennent de sa bouche.

Pourquoi ce format

Un fichier structuré par praticien, un par acte. C'est lisible par un humain, exploitable par un générateur, et versionnable. **Le plan de contenu, l'étude de spécialité et le site sont le même objet à trois moments.**

Le champ qui protège

`vérifié_le` et `signé_par` sur chaque contenu. Sans eux, pas de publication. C'est la boucle de signature de la plateforme de marque, inscrite dans la structure des données plutôt que dans une promesse.

Budgets de performance *et d'accessibilité.*

Des seuils chiffrés, vérifiés à chaque livraison. Un site qui les dépasse ne part pas. C'est ce qui transforme *un beau site est un site rapide* en règle opposable.

Performance

MESURE	SEUIL	RÉFÉRENCE AUDITÉE
Poids transféré, page d'acte	< 250 Ko	155 Ko chez eux
Requêtes réseau	< 15	8 chez eux
Domaines tiers	0	0 chez eux
Cookies	0	0 chez eux
Contenu interactif, mobile 4G	< 2 s	≈ 1,1 s en bureau
Polices chargées	≤ 3 fichiers	3, hébergées sur le domaine
Images au premier écran	≤ 1	format moderne, dimensionnée

Aucun de ces seuils n'exige de prouesse. Ils exigent seulement de ne pas ajouter ce dont on n'a pas besoin. **La performance n'est pas une optimisation, c'est une abstention.**

Accessibilité et lisibilité

MESURE	SEUIL
Corps de texte, pages patient	≥ 17 px
Contraste, texte courant	≥ 4,5
Contraste, grands titres	≥ 3
Longueur de ligne	60 à 75 signes
Zone tactile minimale	44 × 44 px
Navigation au clavier	complète, focus visible
Texte alternatif	sur chaque image porteuse de sens
Texte justifié	jamais
Contenu dépendant du survol	aucun

Pourquoi dix-sept pixels

L'âge médian d'un patient qui cherche un spécialiste est élevé, et la lecture se fait le soir, sur un téléphone, souvent avec inquiétude. Seize pixels est le minimum courant du métier. Dix-sept est notre plancher, et il se voit.

L'accessibilité n'est pas ici une conformité, c'est l'accueil rendu mesurable. C'est le mot élu de la plateforme de marque, traduit en pixels.

Les dix contrôles avant mise en ligne

- **oui** Tous les seuils ci-dessus vérifiés, sur mobile et sur bureau.
- **oui** Balisage sans erreur, un seul bloc par page, aucun nœud orphelin.
- **oui** Chaque page d'acte porte ses onze sections, aucune vide.
- **oui** Chaque affirmation médicale signée par le praticien, et datée.
- **oui** Aucun avis, aucun avant-après, aucun superlatif, aucune comparaison.
- **oui** Honoraires et dépassements écrits en clair sur la page dédiée.
- **oui** Anciennes adresses redirigées une à une, sans chaîne.
- **oui** Fiches externes mises en cohérence : annuaire de l'Ordre, cartographie, agenda, clinique.
- **oui** Mesure des demandes de rendez-vous branchée et testée.
- **oui** Identifiants et domaine remis au praticien, par écrit.

Cette liste est la section 10 du fichier de spécification. Elle se passe à chaque livraison, sans exception, et elle se signe.

Six structures. *Trois au lancement.*

Un template se définit par le **type de pratique**, jamais par une esthétique. Ce qui change d'un template à l'autre, c'est la page pivot, celle qui porte la décision du patient. Tout le reste est identique, et c'est ce qui rend le système tenable.

	TEMPLATE	POUR QUI	LA PAGE PIVOT	CE QUI CHANGE
01	Interventions LANCEMENT	Chirurgien plasticien, orthopédiste, viscéral, bariatrique. La décision porte sur un geste.	La page d'acte.	Pôles par zone du corps. Vingt à cinquante actes. Le parcours de soin et le devis sont centraux.
02	Pathologies et suivi LANCEMENT	Dermatologue, gynécologue, ORL médical, ophtalmologiste médical. La décision porte sur un symptôme.	La page de pathologie.	Pôles par motif de consultation. La pathologie précède l'acte et y renvoie. Le suivi dans la durée est mis en avant.
03	Cabinet de groupe LANCEMENT	Centre, clinique, association de praticiens. Marque collective et praticiens individuels.	La page praticien.	Deux niveaux de marque. Chaque acte indique qui le pratique. Règles de préséance écrites au contrat.
04	Parcours long	PMA, obésité, chirurgie bariatrique, oncologie de suivi. La décision porte sur un chemin de plusieurs mois.	La page parcours, étape par étape.	Le parcours devient le contenu principal. Chaque étape a sa page, ses délais, ses documents.
05	Plateau technique	Chirurgie réfractive, implants, imagerie. La technique et l'équipement font la différence.	La page technique.	Une page par technologie, reliée aux actes qu'elle permet. Les critères d'éligibilité sont détaillés.
06	Installation	Praticien qui s'installe ou déménage. Porte 01 de la plateforme de marque.	La page praticien et le cabinet.	Dix pages, palier Identité. Les pôles arrivent au palier suivant, sans refonte.

Ce qui ne change jamais, quel que soit le template

- Les douze types de page.
- Les vingt composants.
- Le squelette d'acte en onze sections.
- Le système d'adresses et le maillage.
- Le balisage et ses interdictions.
- Les budgets de performance et d'accessibilité.
- L'encart réglementaire et la ligne de vérification.
- La boucle de signature.

C'est ce socle commun qui permet de promettre le dernier site : une refonte devient un changement d'habillage sur la même structure, quelques heures et non un projet. **Six templates, un seul système.**

L'habillage, par-dessus

Trois sentiments choisis avec le praticien pendant l'entretien, puis une palette, un accent typographique, un rythme. Le cadrage a raison de refuser le mot sur-mesure : la formule tenable est **une structure éprouvée, un habillage qui vous ressemble.**

Un template de structure multiplié par un habillage donne assez de combinaisons pour que deux confrères d'une même ville n'aient jamais le même site, sans jamais sortir du système.

Sept écarts. *Aucun n'est cosmétique.*

Ce que le template lisadoc porte et que le meilleur site du marché ne porte pas. Chacun est vérifiable par le praticien, et chacun coûte quelque chose. C'est à cela qu'on reconnaît un vrai différenciateur.

- 01 **Le mot du praticien sur chaque page d'acte.** Trois à cinq phrases de sa bouche, signées, datées. Coût : quarante-cinq minutes d'entretien et un travail de transcription. Impossible à copier, y compris par une IA qui lirait tout le site.
- 02 **L'attribution vérifiable.** Numéro RPPS déclaré, auteur et date de vérification sur chaque contenu. Le site cesse d'être un texte anonyme et devient une source identifiée, reliée à un registre d'État.
- 03 **Les sources citées.** Deux à quatre renvois par page d'acte vers les autorités sanitaires et les sociétés savantes. Personne ne le fait sur ce marché. C'est ce qui distingue une page d'information d'une page de vente déguisée.
- 04 **La brique de questions vivante.** Le seul contenu du site qui grandit sans nous. Au bout d'un an, une page d'acte porte des dizaines de questions réelles, dans les mots des patients, avec des réponses signées.
- 05 **Le prix affiché, totaux compris.** Eux ne publient rien. Sur un marché où le praticien redoute d'être pris pour une cible, publier le prix est un acte de respect avant d'être un acte commercial.
- 06 **Onze spécialités, une méthode.** Leur dispositif ne sort pas de l'esthétique. Le nôtre est conçu dès le départ pour transposer : le pôle change de nom, le squelette ne change pas.
- 07 **La propriété remise.** Domaine, hébergement, identifiants, contenus, ouverts au nom du praticien et remis. Le badge du concurrent disparaît quand on part. Chez nous, c'est le site qui reste.

Le seul écart qui se voit en trois secondes

Les six premiers demandent qu'on lise. Le septième se prouve en une phrase, au téléphone, et il retourne toutes les objections :

Demandez à votre agence actuelle *qui détient le nom de domaine.*

Cette phrase est déjà dans le cadrage. L'audit confirme qu'elle vise juste : c'est la question que personne dans ce métier n'aime entendre.

Ce que nous n'aurons pas avant longtemps

Deux cents pages indexées, un test automatique de conformité, et une antériorité de référencement. Ces trois choses ne s'achètent pas et ne se rattrapent pas en un trimestre.

Conséquence à assumer : les douze premiers mois ne se gagneront pas sur le référencement de lisadoc, mais en entretiens directs, en congrès, et par les confrères. Le référencement viendra après, porté par les sites clients.

Pourquoi ça marche, *en trois minutes.*

Le praticien n'achètera pas une architecture. Il achètera une explication qu'il peut répéter à son associé. Cinq temps, dans cet ordre, sans notes.

Temps 1 • le déplacement, pas le défaut • 25 secondes

On ne cherche plus un médecin comme avant. Aujourd'hui, on tape ce qu'on a, pas le nom de quelqu'un. Votre nom arrive après, quand un confrère vous a recommandé et qu'on vérifie. Ce n'est pas vous qui avez changé, c'est l'usage.

Temps 2 • la rencontre qui n'a pas lieu • 30 secondes

Ce que les gens cherchent, vous l'expliquez déjà vingt fois par semaine en consultation. Combien de temps ça dure, si c'est douloureux, quand on reprend le travail, ce qui est remboursé. Ces réponses existent, elles sortent de votre bouche tous les jours. Elles ne sont simplement écrites nulle part.

Temps 3 • la contrainte devient l'avantage • 40 secondes

Vous êtes l'un des rares professionnels à qui la loi interdit d'acheter de la visibilité. Vous n'avez pas le droit à la publicité. Mais vous avez le droit d'informer, c'est même écrit dans votre code. Et il se trouve que l'information factuelle, sans promesse et sans superlatif, c'est exactement ce que Google met en avant et ce que les IA acceptent de citer. Ce qui vous limite est aussi ce qui vous protège : vos concurrents ne peuvent pas acheter la place non plus.

Temps 4 • la structure, montrée • 45 secondes

Concrètement : une page par intervention que vous pratiquez. Chaque page répond dans l'ordre où la question se pose : ce que c'est, si c'est pour vous, comment ça se passe, les suites, les risques, le prix, puis les questions fréquentes. Et sur chaque page, trois phrases de vous, signées. C'est ça qui fait qu'aucun autre site ne peut ressembler au vôtre.

Temps 5 • ce que ça vous coûte en temps • 20 secondes

De votre côté : un formulaire déjà rempli aux trois quarts que vous corrigez, quarante-cinq minutes d'entretien où vous me racontez votre pratique, et une validation. Ensuite, vous ne vous en occupez plus. Et rien ne se publie sans votre signature.

Les trois erreurs à ne pas commettre

Ne pas commencer par le référencement. C'est le mot qui fait décrocher. Le référencement est la conséquence, pas le sujet.

Ne pas décrire son site actuel. Même quand il est mauvais. Le cadrage l'interdit et c'est juste : on situe le manque dans la rencontre entre l'offre et la demande, jamais dans le médecin.

Ne pas faire peur. Le concurrent ouvre par l'infraction et l'exposition. Cela convertit. Cela fabrique aussi une relation qui commence par une menace. Notre ouverture est un cadeau : l'étude de sa spécialité, offerte, sans engagement.

Le test du bouche-à-oreille

Le script est réussi si le praticien peut le redire à un confrère en deux phrases, sans nous. La cible est celle du cadrage :

Il y a un type qui fait les sites de notre spécialité. Il t'interroge une fois, tu n'as rien à faire, et il connaît la déontologie mieux que nous.

Sept étapes, *avec une machine.*

Ce document a été écrit pour être exécutable. Voici l'ordre dans lequel la structure se construit, ce que chaque étape produit, et ce qui doit rester humain.

ÉTAPE	CE QUI ENTRE	CE QUI SORT	HUMAIN
01 Le socle	Le fichier de spécification, page 26.	Projet statique, douze gabarits vides, vingt composants, jetons de style.	Le choix du générateur. Une fois pour toutes.
02 La grille d'actes	La nomenclature de la spécialité, les volumes de recherche nationaux.	La liste complète des actes et pathologies, à cocher sur quatre niveaux.	Le tri final. Une nomenclature mal découpée fausse tout le site.
03 L'entretien	Le formulaire pré-rempli, la grille cochée.	Enregistrement, transcription, verbatims repérés.	Entièrement humain. C'est le produit.
04 Les fiches	Transcription, grille, sources documentaires.	Une fiche structurée par acte, tous champs remplis.	Le contrôle des faits médicaux et le choix des verbatims.
05 La génération	Les fiches, les gabarits.	Toutes les pages, le balisage, le maillage, le plan de site.	Rien. C'est mécanique, et c'est voulu.
06 La relecture	Le site généré.	Un document unique, affirmations médicales surlignées, bon à publier.	Le praticien signe. Trois tours maximum.
07 La mise en ligne	Le bon à publier.	Site en ligne, fiches mises en cohérence, mesure branchée.	Le contrôle des seuils de la page 21.

Ce qui peut être confié à une machine, et ce qui ne peut pas

Confiable : la génération des gabarits, le balisage, le maillage, les variantes d'habillage, la mise en forme des fiches, la première rédaction des sections 01, 02, 04, 05, 06 à partir des sources, la vérification des seuils techniques.

Non fiable : l'entretien, le choix des verbatims, l'exactitude médicale, les délais réels de la pratique du praticien, les contre-indications qu'il retient, et la décision de publier.

La ligne est simple et se dit devant un médecin sans embarras : **une machine met en forme, un praticien engage sa responsabilité.** Le cadrage l'écrit déjà pour la brique de questions, et cela vaut pour tout le site.

L'ordre qui fait gagner du temps

Construire le site de démonstration **avant** le premier client, sur une praticienne réelle qui accepte de servir de cas d'école. C'est le choix du cadrage, et c'est le bon.

Le concurrent a fait la même chose avec une praticienne fictive. Le faire avec une praticienne réelle donne le même outil de vente, plus une preuve.

Une fois ce premier site construit, les six templates se dérivent de lui. Le deuxième site coûte le tiers du premier. Le cinquième, le dixième.

Le fichier *que la machine lit.*

Ce document est fait pour être lu par vous. Son jumeau, `BUILD-SPEC.md`, est fait pour être donné tel quel à une IA de développement. Il est livré avec ce dossier.

Ce que contient `BUILD-SPEC.md`

- 01 • PRINCIPE
la règle directrice, les interdits
- 02 • ARBORESCENCE
les 12 types, le système d'adresses
- 03 • GABARITS
par type : sections, ordre,
budget de mots, composants appelés
- 04 • PAGE D'ACTE
les 11 sections, in extenso,
avec le rôle de chacune
- 05 • COMPOSANTS
les 20 briques, leur contenu,
leur comportement mobile
- 06 • MODÈLE DE DONNÉES
fiche praticien, fiche acte,
fiche question • format YAML
- 07 • BALISAGE
un gabarit JSON-LD par type,
les interdits de balisage
- 08 • JETONS DE STYLE
couleurs, typographie, espacement,
les trois sentiments
- 09 • BUDGETS
performance, accessibilité,
seuils de refus
- 10 • CONTRÔLES DE LIVRAISON
la liste à passer avant mise en ligne

Comment s'en servir

Trois usages, dans l'ordre où ils se présenteront.

- 01 **Construire le socle.** Donner le fichier entier à une IA de développement avec une consigne d'une ligne : construis le projet statique décrit dans cette spécification, sans rien y ajouter. Ce qui sort est un site vide mais complet, gabarits et composants inclus.
- 02 **Générer un site client.** Donner le fichier plus les fiches remplies d'un praticien. Ce qui sort est le site de ce praticien, à relire.
- 03 **Vérifier une livraison.** Donner le fichier plus l'adresse du site. La section 10 sert de liste de contrôle.

La règle d'or de ce fichier

Il décrit une structure, jamais un contenu médical. Aucune phrase de page d'acte n'y figure, aucune valeur clinique, aucun délai.

Une machine peut construire le contenant. Le contenu vient de l'entretien et repart signé. Si un jour cette limite est franchie, l'écart avec une agence ordinaire disparaît, et la promesse de la plateforme de marque avec.

Ce qui reste à écrire dedans

Les sections 01 à 07 et 09 à 10 se déduisent de ce document. La section 08, les jetons de style, attend deux décisions : la palette du template et le couple typographique. Elles se prennent au moment du premier site, avec la praticienne.

Six décisions, *puis on construit.*

L'audit est clos. Le blueprint tient. Ce qui reste relève de vous.

- 01 **La spécialité du lancement.** Éviter la chirurgie esthétique, tenue par un acteur outillé. Choisir une spécialité de la liste où vous avez déjà un praticien qui vous fait confiance.
- 02 **Le template d'entrée.** Interventions, pathologies ou groupe. Le choix découle de la spécialité, pas l'inverse.
- 03 **Le diagnostic automatique.** Copier ou non leur test de conformité en cinq minutes. C'est le seul élément de leur dispositif que je recommande de reprendre, et il demande du développement.
- 04 **Le renforcement de la rétention.** Leur badge disparaît au départ. Notre équivalent honnête reste à inventer, ou à assumer comme absent.
- 05 **Les jetons de style du template.** Palette et typographie, à arrêter avec la première praticienne.
- 06 **Le calendrier de publication de lisadoc.fr.** Ils ont 206 000 mots d'avance. Le rattrapage frontal n'a pas de sens. La question est de savoir combien d'heures par semaine vous acceptez d'y consacrer, et à partir de quand.

Ce que dit cet audit, en une phrase

Le meilleur site du marché a été construit par quelqu'un qui a compris avant les autres que la déontologie était un actif. Il a bâti un appareil remarquable et n'a pas encore de clients à montrer.

L'architecture est copiable en quelques semaines.
L'entretien avec le praticien ne l'est pas.

Ils écrivent *sur* le praticien.
Nous écrivons *à partir* du praticien.
Toute la différence est là, et elle tient
en trois phrases par page.